

## CONSENTIMIENTO INFORMADO

### DECORTICACIÓN PULMONAR Y TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE FRACTURAS COSTALES en el traumatismo de tórax (evacuación de hemotórax retenido, con o sin reducción y osteosíntesis costal)

|                         |                                                                       |                     |               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| Apellido y Nombre       | [Apellido y Nombre del paciente]                                      |                     |               |
| DNI                     | [DNI]                                                                 | Fecha de nacimiento | [__/__/__]    |
| Edad                    | [Edad]                                                                | Sexo                | [Sexo]        |
| Domicilio               | [Domicilio completo]                                                  |                     |               |
| Obra Social             | [Obra Social]                                                         | Nº de afiliado      | [Nº Afiliado] |
| Institución / Sanatorio | [Nombre del Sanatorio]                                                | Fecha del acto      | [__/__/__]    |
| Médico interviniente    | Dr. Pablo Maynard — Cirujano Torácico UBA — M.N. 121828 / M.P. 232938 |                     |               |

## 1. DIAGNÓSTICO

[Completar diagnóstico específico del paciente — ej.: traumatismo de tórax con fracturas costales múltiples y hemotórax retenido/coagulado / tórax inestable (volet costal) postraumático / hemotórax postraumático sobreinfectado, etc.]

## 2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Bajo anestesia general, se accede a la cavidad pleural —por videotoracosopia (VATS) y/o toracotomía, según la magnitud de las lesiones— para evacuar el hemotórax retenido o coagulado y liberar la corteza fibrosa que restringe la expansión del pulmón (decorticación), producto de la organización de la colección hemática postraumática. Cuando existen fracturas costales múltiples con desplazamiento significativo y/o tórax inestable (volet costal), se procede además a la reducción y fijación (osteosíntesis) de los arcos costales fracturados mediante placas y tornillos específicos para hueso costal, y/o a la resección de fragmentos costales no viables que no puedan fijarse.

## 3. OBJETIVO Y BENEFICIOS ESPERADOS

Evacuar el hemotórax retenido/coagulado para evitar su organización en fibrotórax y la consecuente pérdida permanente de función pulmonar; controlar el foco infeccioso en caso de hemotórax sobreinfectado (empiema postraumático); y, cuando corresponde, estabilizar la pared torácica mediante la reducción y osteosíntesis de las fracturas costales, mejorando la mecánica ventilatoria, reduciendo el dolor asociado a la inestabilidad costal y facilitando el retiro de la asistencia respiratoria mecánica en los pacientes que la requieran.

## 4. RIESGOS Y COMPLICACIONES POSIBLES

### 4.1 Riesgos generales de la anestesia y de la cirugía torácica

- Reacciones a la anestesia general, complicaciones cardiovasculares o respiratorias.
- Sangrado intraoperatorio y/o postoperatorio, con eventual necesidad de transfusión de hemoderivados (frecuentemente ya requerida por el propio traumatismo).
- Infección de la herida quirúrgica.

- Neumonía y/o atelectasia postoperatoria, de particular relevancia en el paciente con contusión pulmonar asociada.
- Arritmias cardíacas postoperatorias.
- Trombosis venosa profunda y/o tromboembolismo pulmonar, con riesgo aumentado en el paciente politraumatizado.
- Insuficiencia respiratoria postoperatoria, con eventual necesidad de asistencia respiratoria mecánica prolongada.
- Necesidad de reoperación.
- Muerte, como riesgo posible de todo procedimiento quirúrgico mayor bajo anestesia general, con mayor probabilidad en el contexto de politraumatismo grave asociado.

#### **4.2 Riesgos de la evacuación del hemotórax y la decorticación pulmonar**

- Sangrado por decorticación de superficies inflamadas, coaguladas o friables, en ocasiones con requerimiento transfusional.
- Fuga aérea prolongada por lesión de la superficie pulmonar, agravada por la fragilidad del parénquima contundido.
- Lesión pulmonar adicional durante la manipulación quirúrgica o por los propios fragmentos costales desplazados.
- Edema pulmonar de reexpansión.
- Reexpansión pulmonar incompleta, con espacio pleural residual.
- Persistencia o desarrollo de infección pleural (empiema postraumático), con necesidad de drenajes adicionales o de una nueva intervención.
- Nuevo neumotórax y/o hemotórax en el postoperatorio.

#### **4.3 Riesgos específicos de la reducción y osteosíntesis de fracturas costales**

- Malposición, aflojamiento o migración del material de osteosíntesis (placas y tornillos), con eventual necesidad de reintervención para su recolocación.
- Infección del material de osteosíntesis, que puede requerir su retiro.
- Falta de consolidación ósea de los arcos costales fijados (pseudoartrosis costal) o consolidación en posición viciosa.
- Lesión del paquete vasculonervioso intercostal durante la reducción/fijación, con dolor neuropático crónico en el trayecto de la incisión.
- Persistencia de dolor torácico crónico postraumático, independientemente de la correcta realización técnica del procedimiento.
- Estabilidad de la pared torácica insuficiente pese a la fijación, con compromiso residual de la mecánica respiratoria.
- Deformidad estética y/o funcional residual de la pared torácica.
- En pacientes politraumatizados con contusión pulmonar extensa: mayor riesgo de síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), de sepsis de foco pulmonar/pleural, y en general un riesgo anestésico-quirúrgico global aumentado en relación con las lesiones asociadas (no exclusivamente atribuible a este procedimiento).
- Mayor tiempo de asistencia respiratoria mecánica y de internación en los pacientes con tórax inestable extenso, aun habiéndose realizado la fijación costal.

## **5. ALTERNATIVAS TERAPÉUTICAS**

Manejo conservador con analgesia multimodal (incluyendo bloqueos regionales) y kinesioterapia respiratoria intensiva, sin cirugía, en fracturas costales no complicadas o hemotórax de pequeño volumen; colocación de tubo de drenaje pleural exclusivo (avenamiento) sin decorticación quirúrgica cuando el hemotórax es evacuable por este medio y no se encuentra retenido/organizado; en el tórax inestable, ventilación mecánica prolongada como "férula neumática interna" sin fijación quirúrgica de las costillas (con mayor tiempo de asistencia respiratoria, mayor riesgo de neumonía asociada al respirador y de traqueostomía); videotoracoscopia o toracotomía evacuadora sola, sin osteosíntesis costal, cuando la inestabilidad de la pared no es significativa.

## 6. CONSECUENCIAS DE NO REALIZAR EL PROCEDIMIENTO

Organización del hemotórax retenido en fibrotórax, con atrapamiento pulmonar y pérdida permanente e irreversible de función respiratoria; desarrollo de empiema postraumático con riesgo de sepsis; en el tórax inestable no corregido, mayor tiempo de ventilación mecánica, mayor riesgo de neumonía asociada al respirador, dolor crónico y deformidad de la pared torácica; en los casos más graves, insuficiencia respiratoria que puede comprometer la vida del paciente.

## 7. DECLARACIÓN DEL PACIENTE

Declaro que el Dr. Pablo Maynard y su equipo me han explicado, en lenguaje claro y comprensible, mi diagnóstico, el procedimiento propuesto, sus beneficios esperados, los riesgos y complicaciones posibles —generales y específicos—, las alternativas terapéuticas disponibles y las consecuencias previsibles de no realizar el procedimiento. He tenido la oportunidad de formular todas las preguntas que consideré necesarias y las mismas fueron respondidas de manera satisfactoria. Comprendo que la Medicina no es una ciencia exacta y que no se me ha garantizado un resultado determinado. En consecuencia, presto mi consentimiento libre, voluntario e informado para la realización del procedimiento descrito en el presente documento, incluyendo los procedimientos anestésicos necesarios para su realización.

## 8. AUTORIZACIONES ADICIONALES

- ☐ Autorizo la ampliación o modificación del procedimiento planificado si, durante el acto operatorio, surgieran hallazgos imprevistos que a criterio del equipo actuante hagan necesario o conveniente dicho cambio para preservar mi salud o mi vida.
- ☐ Autorizo la administración de hemoderivados (transfusión) en caso de ser necesario.
- ☐ Autorizo el envío de las muestras/tejidos obtenidos a estudio anatomopatológico y, de corresponder, a estudios moleculares/genéticos complementarios.
- ☐ Autorizo la toma de fotografías/videos del procedimiento con fines académicos y/o de docencia, resguardando mi identidad (Art. 8º, Ley 26.529). En caso de no autorizar, tildar la opción correspondiente:
- ☐ No autorizo la toma de fotografías/videos con fines académicos.

## 9. REVOCABILIDAD DEL CONSENTIMIENTO

Entiendo que este consentimiento puede ser revocado por mí en cualquier momento previo a la realización del procedimiento, sin necesidad de expresar causa y sin que ello genere consecuencia negativa alguna sobre mi atención médica posterior (Art. 10, Ley 26.529).

10. FIRMAS

|                                                                                                                                       |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Firma: _____</p> <p><b>PACIENTE —</b></p> <p><b>Nombre:</b> _____</p> <p><b>DNI:</b> _____</p>                                     |                                                                                                             |
| <p>Firma: _____</p> <p><b>REPRESENTANTE LEGAL (si corresponde) — Nombre:</b> _____</p> <p><b>DNI:</b> _____ <b>Vínculo:</b> _____</p> |                                                                                                             |
| <p>Firma y sello:</p> <p>_____</p> <p><b>MÉDICO INTERVINIENTE</b></p>                                                                 | <p>Firma: _____</p> <p><b>TESTIGO (opcional) —</b></p> <p><b>Nombre:</b> _____</p> <p><b>DNI:</b> _____</p> |